

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Insertion of Insertion of Suburethral and Midurethral Tape for Stress Incontinence and Cystoscopy

إدخال الشريط تحت -إحليلي و منتصف الإحليلي لعلاج سلس البول ومنظار المثانة البولية

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is a qualified Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:

The damaged ligaments are replaced by a 1cm wide tape of synthetic mesh. This tape returns the support for the urethra (this is the tube that leads from the bladder to the outside) to the surrounding tissues. This is routinely followed by looking into the bladder to make sure no damage has been done (cystoscopy).

C. Risks of insertion of suburethral and midurethral tape and cystoscopy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The bladder may be over-active after the operation. You may need to go to the toilet a lot, may have sudden urges to pass urine and may leak urine. These symptoms are usually managed by bladder retraining and drug therapy. A small proportion of patients will continue to have long - standing bladder symptoms despite treatment.
- Problems with passing urine are uncommon. This rarely

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ لا ☐ نعم
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟ ☐ لا ☐ نعم

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :

يتم استبدال الأربطة المتضررة بشبكة من شريط صناعي بعرض 1 سنتيمتر. يعيد هذا الشريط الدعم لقناة مجرى البول (الأنبوب الواصل بين المثانة البولية وخارج الجسم) مع الأنسجة المجاورة لها . ويتم بشكل روتيني معتمد إتباع ذلك بإجراء منظار للمثانة البولية للتأكد من عدم تضررها.

ج. مخاطر إدخال الشريط تحت -إحليلي و منتصف الإحليلي ومنظار المثانة البولية

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد يزداد نشاط المثانة البولية بعد الإجراء. قد تضطربين للذهاب بكثرة إلى دورة المياه . قد تشعرين برغبة مفاجئة في التبول وقد يتسرب البول . يمكن السيطرة على هذه الأعراض بإعادة تمرين المثانة البولية وبالأدوية . عند نسبة بسيطة من المرضى ، تستمر أعراض المثانة البولية لفترة طويلة بالرغم من تناول العلاج.
- مشاكل التبول غير شائعة . من النادر أن يتطلب ذلك علاج لفترة طويلة. وعند حدوث ذلك فقد يتم تقسيم الشريط عبر الشق المهبلي . هناك نسبة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

needs long term management. If this happens, the tape may be divided through the vaginal cut. There is a small risk of the urinary incontinence returning.

- Infection requiring antibiotics and further treatment.
- Excessive bleeding. This is rare.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- A higher risk in smokers. This may cause wound and chest infections, heart and lung problems and blood clots in the veins.
- The urethra (the tube that leads from the bladder to the outside) can sometimes be damaged.
- The bladder can sometimes be damaged.
- The tape may erode through the urethra in the years after the operation. This would need repair of the urethra and a catheter for 2 weeks.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed).

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained:

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.

خطر بسيطة بعدة سلس البول.

- حدوث عدوى تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- من النادر حدوث النزيف المفرط.
- عند ذوات الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى التهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- عند المدخنات تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية في الأوردة.
- قد يحدث ضرر أحياناً لقناة مجرى البول (الأنبوب الواصل بين المثانة وخارج الجسم).
- قد يحدث أحياناً ضرر للمثانة البولية.
- بعد سنوات من الإجراء ، قد يحدث الشريط تآكلاً في جدار قناة مجرى البول. يتطلب ذلك إصلاح قناة مجرى البول ووضع قسطرة بولية لأسبوعين.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب بالمعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسين حالتي

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ About Your Anaesthetic
- ☐ Epidural and Spinal Anaesthetic
- ☐ Insertion of Suburethral or Midurethral Tape and Cystoscopy

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of Doctor/delegate:

.....

Designation:

Signature:

Date:

- المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية. احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي.
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
- ☐ التخدير النصفي (التخدير الشوكي أو تخدير فوق الجافية)
- ☐ إدخال الشريط تحت -إحليلي ومنتصف الإحليلي ومنظار المثانة البولية

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيع لي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك القدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.
اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار

.....

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name:
Signature:
Date: Time:
2) Name:
Signature:
Date: Time:

الشهود (على التوقيع أعلاه)

(1) اسم :
التوقيع :
التاريخ : الوقت :
(2) اسم :
التوقيع :
التاريخ : الوقت :